Berater/in (Name/Vorname, Nr.) Petra Förster	**Dienstag, 27. Oktober 2026** **Uhrzeit**	☐ Anfrage ☐ Folgeanruf ☐ Tier ☐ FU-B ☐ FU-Tel	**AZ**

Anrufer ☐ Laie ☐ Klinik / KH ☐ Praxis ☐ RTW ☐ Notarzt ☐ KV-Notdienst ☐ Leitstelle ☐ Veterinär ☐ Sonstige:

Quellen
□ BonnTox
□ Mühlendahl
□ Poisindex
□ Toxinz
□ GESTIS
□ TDI
□ SDB
□ EVA

Name
☐ Frau
☐ Herr

TELEFON / ggf. E-Mail

PLZ / Ort / Klinik / Krankenhaus / ggf. Land

Abteilung ☐ Innere ☐ Psychiatrie ☐ ZNA ☐ Intensiv ☐ Kinderklinik/Pädiatrie ☐ Chirurgie ☐ D-Arzt ☐ Sonstige:

Patient Name, Vorname oder Tierart

Fall-Nr.

Geburtsdatum

Alter
☐ Jahre ☐ Monate ☐ Tage
☐ Neugeb. (Tag 1-28) ☐ Säugling (Tag 29-365) ☐ Kleinkind (1 – <4 J.)
☐ Kind (4 bis <13 Jahre) ☐ Jugendliche (13 - <18 Jahre) ☐ Erwachsen (18 Jahre und älter)
☐ m ☐ w ☐ div
☐ w-Stillzeit ☐ w-schwanger: **SSW**:

kg
cm

Noxe Zeitpunkt Erstkontakt
☐ vor ☐ um ☐ über
☐ Min ☐ Std ☐ Tage ☐ Monate ☐ Jahre

A **S** **C** **B** **U**

Atiologie
☐ suizidal ☐ akzidentiell ☐ unbekannt ☐ Abusus ☐ Bemerkung:
☐ gewerblich ☐ Nebenwirkung ☐ Umwelt ☐ Psychose ☐ Giftbeibringung

☐ **Ausführungsfehler / Fehlgabe durch nichtärztl. caregiver**
☐ iatrogen durch Arzt/Ärztin selbst falsch angeordnet u./o. appliziert

Ort
☐ Haus ☐ im Freien ☐ Spielplatz ☐ unbekannt ☐ Garten ☐ Bemerkung:
☐ KiGa-KiTa ☐ Schule ☐ Krankenhaus ☐ Behind.heim ☐ Altenheim

Expositionsroute
☐ oral ☐ nasal ☐ inhalativ ☐ Auge ☐ Haut ☐ unbekannt ☐ Bemerkung:
☐ Stich ☐ Biss ☐ rektal ☐ i.v. ☐ i.m. ☐ s.c. ☐ para ☐ Weichteile

Exposition	**Noxe**	**Menge**	
G N K	G N K T	G N U	max
G N K	G N K T	G N U	max
G N K	G N K T	G N U	max
G N K	G N K T	G N U	max
G N K	G N K T	G N U	max
G N K	G N K T	G N U	max
G N K	G N K T	G N U	max

Anamnese (aktuelles Ereignis, ggf. Vorgeschichte) □ Beiblatt

VE ☐ Rückseite / Beiblatt

VM ☐ Rückseite / Beiblatt

Symptome □ keine □ wach und voll orientiert
□ Zusammenhang fraglich

Befunde / Massnahmen vor / bei Anruf

GCS	SpO_2
HF	RR /
QTc	pH
Temp	BZ
Ethanol	→ □ mg/L □ ‰

v	**Therapien und Massnahmen**	e	g
□	Keine	□	□
□	Symptominfo telefonisch □ FAX	□	□
□	Überwachung	□	□
□	Spülen	□	□
□	Flüssigkeit oral □ kohlenhydratreich	□	□
□	Entschäumen □ Butter □ Simeticon	□	□
□	**wg. Noxe Ärztl. Untersuchung**	□	□
□	**wg. Symptom Ärztl. Untersuchung**	□	□
□	Symptomat. Therapie/Massnahmen	□	□
□	Aktivkohle □ repetitiv □ prolongiert	□	□
□	Labor	□	□
□	Blutspiegel □ Ethanol □ Noxe	□	□
□	Antidot □ Flumazenil □ Naloxon	□	□
□	□ ACC □ ACC prolongiert	□	□
□	Volumentherapie i.v.	□	□
□	Verätzungsschema	□	□
□	Cortison □ i.v. □ inhal. □ lokal	□	□
□	Magenspül. □ Endo □ Intub.schutz	□	□
□	Intubation / Beatmung	□	□
□	sek. Giftelim. □ HD □ lipid rescue	□	□
□	Produktinformation □ SDB	□	□
□	Bestimmung Noxe und Wiederanruf	□	□
□	Pilzsachverständige **PSV**	□	□
□	Rückruf durch GIZ	□	□
□	GIZ empfiehlt Kontaktaufn. durch:	□	□

in EVA-1.0 Feld „Zusatz“ beachten
caregiver: □ Familie □ Betreuungseinrichtung
KH/Klinik : □ somatisch □ Psychiatrie
Monitoring: □ Klinik allg. □ Notaufn. □ Intensiv □ IMC

	e	**g**
Benzodiaz	□	□
NaBi	□	□
Mg^{++}	□	□
Katecholamin	□	□
Biperiden	□	□
E`lyt-Subst.	□	□
Glukose	□	□
ß-Blocker	□	□
Vitamin B1	□	□
Lidocain	□	□
Temp.Kontr.	□	□
kühlen	□	□
Physostig	□	□

PSS vor/bei Anruf
⓪ ① ② ③ ④ U

max. PSS potentiell
⓪ ① ② ③ ④ U

wegen Noxe empfohlenes Prozedere
□ keines □ ambulant □ Intensiv / IMC
□ Laie □ stationär □ nicht zu entsch. □ **Beiblatt**